長時間ホルター心電図とヘッドアップティルト試験により診断に至った反射性失神の一例

◎磯村 優[1)]、鈴木 優大[1)]、伊藤 英史[1)]、大嶋 剛史[1)]
医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院[1)]

[はじめに] 反射性失神は、失神原因の約半数を占める。ヘッドアップティルト試験(head up tilt test：HUT)は、反射性失神の診断および病型分類に有用な検査である。今回、病歴聴取および 24 時間ホルター心電図では診断に至らなかったが、長時間ホルター心電図と HUT の併用により確定診断に至った症例を経験したので報告する。

[患者背景] 53 歳男性。再発性失神を主訴に来院した。初発は 2024 年 12 月、自動車運転中の意識消失であった。その後、飲酒後や勤務中にも同様の発作を認め、計 3 回の失神を繰り返した。心エコーおよび 24 時間ホルター心電図では正常範囲内であった。終夜睡眠ポリソムノグラフィーでは軽症睡眠時無呼吸症候群(AHI=9.1)であり、関与は否定的であった。臨床経過および検査所見から反射性失神を疑い、さらなる精査を行った。

[方法・結果] 原因精査のため長時間ホルター心電図（JSR 株式会社 Heartnote）を 6 日間施行したところ、最長 4.43 秒の洞停止を認めた。発作との明確な関連を特定するため、HUT を実施した。5 分間の安静臥位後、60°で 5 分、70°で 20 分の立位負荷を行い、その後ニトロール錠 5mg を舌下投与した。投与 10 分後に血圧低下（138/100 → 86/61 mmHg）および心拍数低下（93 → 40 /分）を認め、同時に洞停止と意識消失を生じたため検査を中止し臥位とした。以上より混合型反射性失神と診断に至った。治療として起立調節訓練を開始後、再発を認めていない。

[考察] 本症例では、長時間ホルター心電図で異常所見を捉え、HUT 併用により失神の発生機序と病型分類を明確に特定し得た。原因不明の失神に対し、多面的な生理機能評価を組み合わせる重要性が示唆された。臨床検査技師は、それぞれの検査特性を理解し、医師へ積極的に提案する役割が求められる。また、HUT のようなリスクを伴う検査の実施体制を整備・運用することは、検査技師の専門性を示すとともに、病院全体の診断精度向上に直結すると考える。

連絡先：0566-25-8117